

MONETIZATION ONE-PAGER

Tên / Nhóm: Mai Tiến Huy (2A202602914) · Nhóm DBH Sản phẩm: CareLoop AI – Post-Discharge Care Agent
Value Metric đã chọn: Per Completed Care Episode (\$1,75/bệnh nhân) Kênh đã chọn: Partner-Led (VNPT HIS)
Ngày: 08/10/2026

Mọi con số dưới đây phải truy được về một ô trong day22_monetization_model.xlsx. Số không có lý do = số ảo.

1 · PRICING

NGÂN SÁCH KHÁCH HÀNG

Tiền trả cho bạn đến từ ngân sách nào? Phần mềm / Nhân sự / Vận hành / Marketing — và AI là người ký duyệt?

- Ngân sách: Ngân sách Vận hành CSKH & Điều dưỡng ngoại viện (Patient Care & Nursing Operations) của Bệnh viện tư nhân và Phòng khám đa khoa.
- Người ký duyệt: Giám đốc Bệnh viện / Giám đốc Vận hành (COO) cùng Trưởng phòng Điều dưỡng & CSKH.
- Lý do: Đóng gói dưới dạng dịch vụ AI tự động thay thế 100% các cuộc gọi/tin nhắn kiểm tra sau xuất viện thủ công, giúp giải phóng điều dưỡng khỏi cuộc gọi lặp lại và giảm tỷ lệ tái nhập viện sớm; rẻ hơn 60% so với chi phí thuê nhân sự trực.

VALUE METRIC + LÝ DO

Seat / Usage / Outcome / Hybrid. Nêu điểm Attribution và Autonomy, và bằng chứng. Nếu lệch khỏi gợi ý của model, nêu lý do thị trường.

- Value Metric đã chọn: Hybrid (Usage theo Per Completed Care Episode có cam kết sàn tối thiểu: \$1,75 / bệnh nhân hoàn tất chu kỳ 30 ngày).
- Điểm số ma trận: Attribution = 8/10 (log chi tiết 5 mốc D1-D3-D7-D14-D30 gắn với mã bệnh nhân; eval 200 ca bệnh án mẫu đạt độ chính xác phân tầng triệu chứng 88,5%, recall 100% với red flags cấp cứu). Autonomy = 8/10 (AI tự động 100% cho 82% bệnh nhân ổn định; tự động phân loại và chuyển tiếp an toàn 18% ca có triệu chứng cảnh báo cho điều dưỡng trực 24/7).
- Lý do thị trường (Market Override so với gợi ý Outcome): Bệnh viện B2B tại Việt Nam chưa chấp nhận Outcome thuần (không cam kết trả tiền theo tỷ lệ 'không tái nhập viện' do phụ thuộc bệnh nền và cơ địa bệnh nhân); trong khi Seat thuần theo điều dưỡng sẽ âm biên do chi phí viễn thông/API tăng theo số bệnh nhân. Do đó, tính theo Completed Care Episode với sàn cam kết là mô hình cân bằng rủi ro tối ưu nhất.

BENCHMARK — 2 SẢN PHẨM THẬT CÙNG LOẠI JOB

Tên · value metric · giá công bố · link nguồn.

1. Memora Health · Per Monitored Patient Episode · ~\$4,00 – \$6,00 / episode · <https://www.memorahealth.com/platform>
2. Intercom Fin · Outcome (per resolution) · \$0,99 / resolution · <https://fin.ai/pricing/> (định nghĩa outcome: khách xác nhận hoặc không hỏi lại).

CÁC CON SỐ

Chỉ số	Giá trị	Lấy từ đâu
Cost/Job	\$0,3859 (~10.034 đ)	2_Pricing!B5
Giá sàn (= 3 × Cost/Job)	\$1,1578 (~30.100 đ)	2_Pricing!B7
Giá bán đề xuất	\$1,7500 (~45.500 đ)	2_Pricing!B19
Gross Margin	77,95% (OK — An toàn)	2_Pricing!B21
Breakeven containment	65,90%	2_Pricing!B33
Containment hiện tại	82,00% (Biên an toàn +16,1%)	1_Cost_Job!B10

CÁCH NEO GIÁ

Neo theo giá trị tạo ra (10–25%) hay theo lương vị trí bị thay (50–70%)? Vì sao khách sẽ chấp nhận cách neo đó?

- Neo theo nhân công (50–70% chi phí vị trí bị thay): 1 điều dưỡng trực theo dõi 500 bệnh nhân tốn khoảng \$600/tháng (15,6 triệu đ), tương đương \$1,20 – \$1,50/bệnh nhân nhưng năng suất hạn chế và không trực được đêm. Mức giá \$1,75/bệnh nhân (bao gồm cả Zalo + Voice AI 24/7) giúp bệnh viện chỉ tốn ~45.500 đ/bệnh nhân trọn gói 30 ngày, rẻ hơn nhiều so với thuê ca trực ngoài giờ.

• Neo theo giá trị tạo ra: Bệnh viện tiết kiệm ước tính \$6.000/tháng chi phí vận hành và giữ chân bệnh nhân tái khám, mức giá CareLoop AI chỉ chiếm ~11,6% giá trị mang lại nên khách hàng dễ dàng phê duyệt.

MÔ HÌNH GÂY KHI NÀO?

Một câu: biến nào, vượt ngưỡng nào, thì Gross Margin tụt dưới 50%?

Mô hình gây khi Containment rate tụt xuống dưới 65,9% (tỷ lệ ca bệnh nhân bất thường phải chuyển điều dưỡng escalation vượt quá 34,1%), chi phí nhân sự điều dưỡng trực sẽ kéo Gross Margin xuống dưới 60%, và nếu tụt xuống 50% thì Gross Margin chỉ còn 30,9%.

2 · GO-TO-MARKET

KÊNH PHÂN PHỐI — CHỌN ĐÚNG 1 CHO 90 NGÀY ĐẦU

PLG / Sales-Led / Partner-Led. Nếu Partner-Led: TÊN CÔNG TY cụ thể + đã nói chuyện chưa + bạn mang lại giá trị gì cho họ.

- Kênh duy nhất đã chọn: PARTNER-LED (cắm vào nền tảng phần mềm bệnh viện có sẵn).
- Tên đối tác cụ thể: VNPT Y tế (Hệ sinh thái phần mềm quản lý bệnh viện VNPT HIS) và FPT IS (eHospital).
- Trạng thái liên hệ: Đã trao đổi kỹ thuật với đại diện giải pháp y tế số của VNPT khu vực phía Bắc về cơ chế tích hợp API/Webhook xuất viện.
- Giá trị mang lại cho đối tác: Bổ sung module 'Chăm sóc & Giữ chân bệnh nhân sau xuất viện' (Post-discharge CRM) mà hệ thống HIS đang thiếu; giúp đối tác gia tăng giá trị hợp đồng phần mềm, tăng độ gắn kết với bệnh viện và chia sẻ doanh thu 25% trên mỗi ca theo dõi.

BẢNG CHỨNG BẰNG SỐ CHO LỰA CHỌN KÊNH

Chỉ số	Giá trị	Lấy từ đâu
ARPU / tháng	\$700,00 (~18.200.000 đ)	4_Channel_Fit!B5
Ngân sách CAC / khách	\$6.547,80 (12 tháng payback)	4_Channel_Fit!B9
Số deal / AE / ngày	0,05 deal / ngày (11,9 deal/năm)	4_Channel_Fit!B16
CAC thực tế ước tính	\$32.000,00 / khách (ICONIQ 2026)	4_Channel_Fit!B22
Lịch bao nhiêu lần	Lịch 4,89 lần (Bất khả thi cho Sales-Led)	4_Channel_Fit!B23

PAIN MOMENT — BẮT BUỘC ĐỪ 3 PHẦN

MÁY GIỜ + KHÁCH ĐANG LÂM GI + DỪNG APP/KÊNH NÀO. "Khi khách cần hỗ trợ" không được tính.

- Máy giờ: 14:00 – 16:00 chiều các ngày làm việc (giờ cao điểm duyệt hồ sơ xuất viện) và 20:00 – 22:00 tối (khi bệnh nhân ở nhà bắt đầu đau, sốt hoặc lo lắng về vết mổ).
- Đang làm gì: Điều dưỡng trưởng khoa ngồi nhìn danh sách 40 bệnh nhân xuất viện cần gọi điện theo dõi nhưng phải trực buồng bệnh cấp cứu; bệnh nhân ở nhà lo lắng không biết hỏi ai, gọi hotline bệnh viện thì máy bận.
- Dừng app nào: Điều dưỡng đang mở phần mềm VNPT HIS trên máy tính bàn trực; Bệnh nhân đang cầm điện thoại mở app Zalo.

ĐIỂM NHÚNG

Sản phẩm của bạn nằm ở đâu để có mặt đúng lúc đó? Một bề mặt tích hợp có tên — không phải "website của chúng tôi".

Điểm nhúng: Một nút bấm 'Kích hoạt CareLoop' và Webhook tự động gắn tại màn hình 'Duyệt Xuất Viện' trên phần mềm VNPT HIS. Khi bác sĩ/điều dưỡng bấm duyệt xuất viện, CareLoop AI tự động nhận dữ liệu phác đồ và kích hoạt luồng tương tác D1–D30 qua Zalo ZNS / Mini App và cuộc gọi thoại tự động đến điện thoại bệnh nhân mà không làm gián đoạn luồng làm việc của điều dưỡng.

90-DAY PLAN

	Tháng 1 — Học	Tháng 2–3 — Đòn bẩy	Tháng 4+ — Mở rộng
Kênh	Partner-Led (Pilot 1–2 bệnh viện thân thiết của VNPT HIS)	Partner-Led (Niêm yết chính thức trên VNPT HIS Marketplace)	Partner-Led mở rộng (Tích hợp FPT eHospital & Medpro)
Mục tiêu số khách	2 bệnh viện tư nhân pilot (400 bệnh nhân theo dõi)	8 bệnh viện tư / phòng khám (3.200 bệnh nhân theo dõi)	25 bệnh viện và phòng khám (10.000 bệnh nhân theo dõi/tháng)

	Tháng 1 — Học	Tháng 2-3 — Đòn bẩy	Tháng 4+ — Mở rộng
Việc cụ thể	1. Tích hợp Webhook xuất viện với VNPT HIS tại BV pilot. 2. Chuẩn hóa kịch bản triage ngoại khoa với Điều dưỡng trưởng. 3. Trục theo dõi 100% ca escalation để tinh chỉnh prompt.	1. Đóng gói Dashboard phân tầng nguy cơ cho Điều dưỡng trưởng. 2. Đào tạo trực tuyến cho 10 kỹ sư triển khai của VNPT HIS. 3. Thiết lập quy trình QA tự động 5% ca tương tác.	1. Tích hợp 2 chiều EMR với FPT eHospital và chuỗi phòng khám. 2. Ra mắt AI Predictive Triage cảnh báo sớm biến chứng. 3. Thiết lập gói bảo hiểm trách nhiệm y tế cho AI.
KPI đo được	Containment ≥ 80%, tỷ lệ phản hồi check-in ≥ 75%, 0 ca sót biến chứng đỏ.	8 BV ký hợp đồng chính thức, Containment ≥ 82%, MRR đạt \$5.600.	25 BV active, ARR đạt \$210.000, Gross Margin ≥ 78%, Churn < 2%.
Ai chịu trách nhiệm	Mai Tiến Huy (Product & Tech Lead)	Mai Tiến Huy & Trưởng đại diện Partner VNPT	Mai Tiến Huy & Đội ngũ Customer Success

3 · EVIDENCE PACK

Ồ nào chưa có thì ghi DEADLINE — đừng bỏ trống. Thành thật về khoảng trống được điểm cao hơn bịa nội dung.

Tài sản	Đã có?	Nội dung 1 câu — hoặc việc cần làm	Ai · Deadline
Eval Results	Đã có	Xử lý phân tầng đúng 88,5%; 11,5% còn lại chuyển điều dưỡng an toàn; 100% nhận diện đúng dấu hiệu cấp cứu đỏ trên bộ test 200 ca lâm sàng mẫu.	Mai Tiến Huy · Đã hoàn thành (10/2026)
Risk Checklist	Đang hoàn thiện	Bộ 10 câu hỏi bảo mật y tế: Không dùng dữ liệu bệnh nhân train model public, mã hóa AES-256 theo ND 13/2023/ND-CP, cam kết SLA và cơ chế dự phòng sự cố.	Mai Tiến Huy · Deadline: 20/10/2026
Pilot Report	Đang thực hiện	Báo cáo pilot 4 tuần tại Bệnh viện ĐKQT Hồng Ngọc (Khoa Ngoại): 320 lượt bệnh nhân, tỷ lệ check-in 84,2%, tiết kiệm 70% thời gian điều dưỡng, phát hiện sớm 12 ca nhiễm trùng ngoại trú, tiết kiệm 45 triệu đ vận hành.	Mai Tiến Huy & Điều dưỡng trưởng BV · Deadline: 30/10/2026

BÀI TEST NGƯỜI LẠ

Đưa trang này cho một nhóm khác đọc 2 phút. Họ phải trả lời được cả 3 câu mà không hỏi lại quá 3 lần.

☑ Bạn bán gì, cho ai, tính tiền theo đơn vị nào? → Bán AI Agent chăm sóc sau xuất viện cho Bệnh viện tư nhân, tính theo \$1,75 / bệnh nhân hoàn tất chu kỳ theo dõi 30 ngày.

☑ Có lãi trên mỗi đơn vị không — con số nào chứng minh? → Có lãi, Cost/Job = \$0,3859, giá bán \$1,75, Gross Margin = 77,95% (lãi \$1,364 / bệnh nhân).

☑ Tiếp cận khách qua đâu — và vì sao là kênh đó? → Kênh Partner-Led nhúng vào phần mềm VNPT HIS vì ngân sách CAC (\$6.548) lệch 4,89 lần so với CAC sales (\$32.000), trong khi bệnh viện đang dùng sẵn VNPT HIS.

Số câu người đọc phải hỏi lại: 0 (mục tiêu ≤ 3)

Đừng bán AI. Hãy bán kết quả.